BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG HOSPITAL

Chuyên sâu – Tận tâm – Vươn tầm

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

Mã hiệu: **XN.QL.24.02** - Bản số: .....**XN**

Ngày hiệu lực : ..12/..05./2026

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Trưởng khoa Vi sinh	Biên soạn	**Đào Quang Trung**	
Trưởng khoa HH-TM	Kiểm soát chung	**Nguyễn Hoài Nam**	
Trưởng khoa Sinh hóa		**Nguyễn Thị Hoa**	
Trưởng khoa GPB		**Đào Thị Nguyệt**	
Phụ trách P. QLCL	Quản lý và ban hành	**Trần Anh Long**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng			
Số bản	**Nơi gửi đi**		**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng		
Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi sinh
		02-04	Khoa HHTM, SH, GPB

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
3	4. Định nghĩa, từ viết tắt, thuật ngữ sử dụng	Bổ sung định nghĩa, từ viết tắt
5	5. Nội dung thực hiện	Bổ sung quy trình nhận diện rủi ro Bổ sung tần suất cho thang điểm đánh giá khả năng xảy ra
7	7. Tài liệu liên quan 8. Tài liệu tham khảo	Bổ sung tài liệu liên quan Bổ sung tài liệu tham khảo

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình nhằm đưa ra cách thức thực hiện hành động kiểm soát rủi ro, mối nguy tiềm ẩn liên quan đến quá trình làm việc nhằm đảm bảo sự an toàn cho nhân viên và khách hàng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng tại khoa Huyết học – Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Giải phẫu bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các nhân viên trong khoa có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.
- Trưởng khoa kiểm soát việc thực hiện để nhận biết và đánh giá rủi ro để đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
- Nhân viên quản lý chất lượng theo dõi, kiểm tra việc đánh giá rủi ro của khoa
- Nhân viên quản lý kỹ thuật thực hiện và phân công cán bộ thực hiện việc nhận biết, đánh giá rủi ro của bộ phận.

4. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

Định nghĩa

- Rủi ro: Là sự kết hợp giữa khả năng có thể xảy ra của mối nguy và mức độ nghiêm trọng của hậu quả gây ra do một mối nguy đã được dự đoán trước.
- Đánh giá rủi ro: Là quá trình ước lượng rủi ro sinh ra từ một (các) mối nguy, có xem xét đầy đủ đến các biện pháp hiện có và quyết định xem rủi ro đó có thể chấp nhận được hay không
- Mối nguy: Là nguồn, tình trạng, hành động hoặc những điều kiện đang tồn tại hay tiềm ẩn có thể gây hư hỏng, tê liệt hệ thống, thiết bị, tài sản hoặc có tổn hại đến con người và môi trường
- Nhận dạng mối nguy: Có thể bao gồm xác định và phòng tránh mối nguy, loại bỏ nguồn rủi ro, loại bỏ khả năng hay hậu quả rủi ro, chuyển hay biến các rủi ro thành các cơ hội để cải tiến, hay chấp nhận rủi ro bằng các quyết định thực hiện
- Quản lý rủi ro: Các hoạt động để kiểm soát hệ thống về mặt rủi ro.
- Khả năng xảy ra: Cơ hội xảy ra một điều gì đó.
- Kiểm soát: Biện pháp làm thay đổi rủi ro.

Từ viết tắt

- TK: Trưởng khoa
- QLCL: Quản lý chất lượng
- QLKT: Quản lý kỹ thuật
- QLAT: Quản lý an toàn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- ATSH: An toàn sinh học

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN

5.1 Quy trình nhận diện rủi ro

- Định kỳ hàng năm, nhân viên QLCL từ "Sổ theo dõi sự không phù hợp", mã tài liệu BM.02.XN.QL.02 tổng hợp sự không phù hợp trong năm và bổ sung các rủi ro vào "Phiếu nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro", mã tài liệu: BM.01.XN.QL.24.
- Nhân viên QLKT phân công nhân viên thực hiện nhận diện rủi ro dựa trên các hoạt động hiện tại của khoa, các điều kiện làm việc cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xét nghiệm, sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên và bệnh nhân hay khi thay đổi hóa chất, máy móc, triển khai một xét nghiệm mới dựa theo tiêu chuẩn đánh giá rủi ro (Mục 5.2) vào "Phiếu nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro", mã tài liệu: BM.01.XN.QL.24.

5.2 Tiêu chuẩn đánh giá rủi ro

- Rủi ro có thể được xem như hậu quả của các mối nguy như khi có quy trình kĩ thuật mới, hóa chất mới, phương pháp mới...
- Tùy vào bản chất của từng mối nguy mà rủi ro có thể khác nhau. Việc đánh giá rủi ro được thực hiện dựa trên khả năng xảy ra và mức độ thiệt hại với công thức:

Mức độ rủi ro = Khả năng xảy ra x Mức độ thiệt hại

5.2.1 Khả năng xảy ra

Điểm	Khả năng	Tần suất	Giải thích
1	Hiếm	<1 lần/năm	Sự cố rất khó xảy ra/chưa từng xảy ra trừ những trường hợp đặc biệt do cố ý hoặc vi phạm quy định hướng dẫn trầm trọng. (Đã có đầy đủ biện pháp kiểm soát như tài liệu quy trình thực hành chuẩn, hướng dẫn, đào tạo, người kiểm tra lại...)
2	Không thường xuyên	Ít nhất 1 lần mỗi năm	Sự cố có thể xảy ra trong một số thời gian do bất cẩn, thực thi thiếu (Đã có quy trình thực hành chuẩn, có hướng dẫn, có đào tạo nhưng chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả)
3	Trung bình	Ít nhất 1 lần mỗi tháng	Sự cố dễ xảy ra trong một số thời gian (Do thiếu quy trình/thiếu hướng dẫn công việc/chưa được đào tạo công việc hoặc chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

4	Thường xuyên	Ít nhất 1 lần mỗi tuần	Sự cố sẽ có thể xảy ra trong hầu hết những trường hợp (Thiếu hết các điều kiện: tài liệu, đào tạo, biện pháp kiểm soát...)
5	Gần như chắc chắn	≥1 lần/ngày	Sự cố được dự tính chắc chắn xảy ra trong hầu hết những trường hợp. (Chắc chắn 100% sẽ bị xảy ra rủi ro khi thực hiện công việc)

5.2.2 Mức độ thiệt hại

Điểm	Mức độ	Giải thích
1	Không đáng kể	Ít hoặc không có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động xét nghiệm
2	Nhẹ	Ảnh hưởng đến quá trình thử nghiệm nhưng mức độ tác động nhỏ, có thể xử lý trong thời gian ngắn.
3	Nặng	Có khả năng gây sai lệch, thiệt hại đến quá trình xét nghiệm, hoạt động của nhóm xét nghiệm bị đình trệ, thiết bị hư hỏng
4	Nghiêm trọng	Kết quả xét nghiệm có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng đến đơn vị và khách hàng: - Hoạt động của khoa bị đình trệ - Thiết bị bị hư hỏng cần sửa chữa bên ngoài - Ảnh hưởng tới sức khỏe nhân viên - Ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân - Ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của khoa
5	Khẩn cấp	Các tình huống phải ban bố khẩn cấp hoặc bị kiện cáo về kết quả xét nghiệm: - Kết quả xét nghiệm sai ảnh hưởng tới kết luận điều trị của bác sĩ - Ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân - Ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân viên - Vi phạm pháp luật - Gây hậu quả đình chỉ hoạt động xét nghiệm - Thiết bị bị phá hủy hoàn toàn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

5.2.3 Ma trận rủi ro

Mức độ rủi ro = Khả năng xảy ra x Mức độ thiệt hại

Khả năng xảy ra		**Mức độ thiệt hại**				
		1	2	3	4	5
		Không đáng kể	Nhẹ	Nặng	Nghiêm trọng	Khẩn cấp
1	Hiếm khi	1	2	3	4	5
2	Không thường xuyên	2	4	6	8	10
3	Trung bình	3	6	9	12	15
4	Thường xuyên	4	8	12	16	20
5	Gần như chắc chắn	5	10	15	20	25

- Từ kết quả đánh giá mức độ rủi ro, TK các khoa thực hiện xếp loại mức độ rùi ro vào BM.01.XN.QL.24.

+ Nếu mức độ rủi ro ở mức 1-5 điểm: Rủi ro chấp nhận được, cần giám sát

+ Nếu mức độ rủi ro ở mức 6-10 điểm: Rủi ro cần hành động để giảm thiểu trong thời gian nhất định

+ Nếu mức độ rủi ro ở mức >12 điểm: Rủi ro cao, chấm dứt hoạt động hoặc có hoạt động khác thay thế phù hợp

- Nhân viên QLCL, nhân viên QLAT phân tích nguyên nhân cho các rủi ro xếp loại ở mức rủi ro cao. Từ đó đưa ra các hành động kiểm soát bổ sung cho các rủi ro này vào BM.01.XN.QL.24. Việc này được thực hiện song song với hoạt động nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro. Riêng đối với các rủi ro xếp loại cao thì phải có kế hoạch thực hiện hành động kiểm soát bổ sung đi kèm.
- TK xét duyệt các rủi ro và nội dung hành động kiểm soát bổ sung cho các rủi ro đó.
- Nhân viên QLAT và các nhân viên được phân công tiến hành khắc phục dựa vào nội dung được xét duyệt trong BM.01.XN.QL.24.
- Nhân viên QLAT lên kế hoạch, đào tạo tập huấn về ứng phó xử lý các tình huống khẩn cấp trong thực tế và báo cáo TK.
- Nhân viên QLCL thực hiện đánh giá hiệu lực các hành động kiểm soát rủi ro và cơ hội theo thời hạn khắc phục.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Nếu không đạt thì báo cáo TK để đưa ra hướng xử lý và triển khai theo hướng xử lý được duyệt. Nếu đạt thì QLCL thực hiện báo cáo kết quả đánh giá hiệu lực cho TK.
- Các hành động khắc phục hoặc hoạt động cải tiến sẽ được thực hiện (nếu có).

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Stt	Tên hồ sơ	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro	BM.01.XN.QL.24	Hồ sơ xem xét hợp đồng-Tủ hồ sơ	5 năm

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên quy trình	Mã tài liệu
Quy trình Kiểm soát tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng	HT.QL.01
Quy trình kiểm soát hồ sơ	XN.QL.27
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	XN.QL.02
Quy trình thực hiện hành động khắc phục	XN.QL.03
Quy trình cải tiến liên tục	XN.QL.25

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ y tế, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành 2014.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- ISO 15189:2022, *Medical laboratories – Requirements for quality and competence*, 2022.
- Cẩm nang an toàn sinh học phòng xét nghiệm, ấn bản lần 4 và các chuyên đề bổ sung (Laboratory Biosafety Manual – 4th Edition), WHO, ban hành 2020.
- Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (2014), TCVN 10547:2014 (ISO/TS 22367:2008), Phòng thí nghiệm Y tế - Giảm sai lỗi thông qua quản lý rủi ro và cải tiến liên tục.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHIẾU NHẬN DIỆN MỐI NGUY, ĐÁNH GIÁ RỦI RO

TT	Nội dung hoạt động cần đánh giá	Mối nguy	Rủi ro có thể xảy ra	Khả năng xảy ra (P)	Mức độ nghiêm trọng (S)	Mức độ rủi ro = (P)*(S)	Nguyên nhân tiềm ẩn của mối nguy	Hành động cần thiết hoặc quá trình kiểm soát để giảm thiểu rủi ro	Trách nhiệm	Thời hạn	Kết quả sau khi thực hiện hành động kiểm soát	Đánh giá hiệu lực	Ghi chú
1													
2													
3													

Người đánh giá

Ngày:

Người kiểm tra

Ngày:

Trưởng khoa

Ngày:

Lưu hồ sơ này cùng tài liệu gốc